

13. EJE CRANEOSACRO PRIMITIVO

DURACIÓN : 03:34

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este vídeo, exploramos en profundidad el eje craneosacro primitivo, que emerge durante la segunda semana del desarrollo embrionario con la formación de la notocorda. La enseñanza destaca la importancia de esta estructura para el cráneo y el sacro, en particular subrayando cómo un sacro libre es esencial para asegurar la funcionalidad de la columna vertebral y la flexo-extensión de la base del cráneo. Además, el vídeo aborda las implicaciones que estas dinámicas embrionarias tienen sobre las patologías urogenitales, y cómo la liberación de ciertos bloqueos emocionales o energéticos entre el sigmoide y la vejiga puede contribuir a un mejor equilibrio global. Los estudiantes aprenderán a manipular estos conceptos para mejorar su práctica en osteopatía y en embriología biodinámica.

EJE CRÁNEO-SACRO PRIMITIVO

Durante la segunda semana de desarrollo embrionario, la **forma en S** del proceso epiblastico comienza a formar la **notocorda**. El **nódulo de Hensen**, o depresión primitiva, se convierte en un punto de apoyo fijo y se desplaza progresivamente hacia atrás.

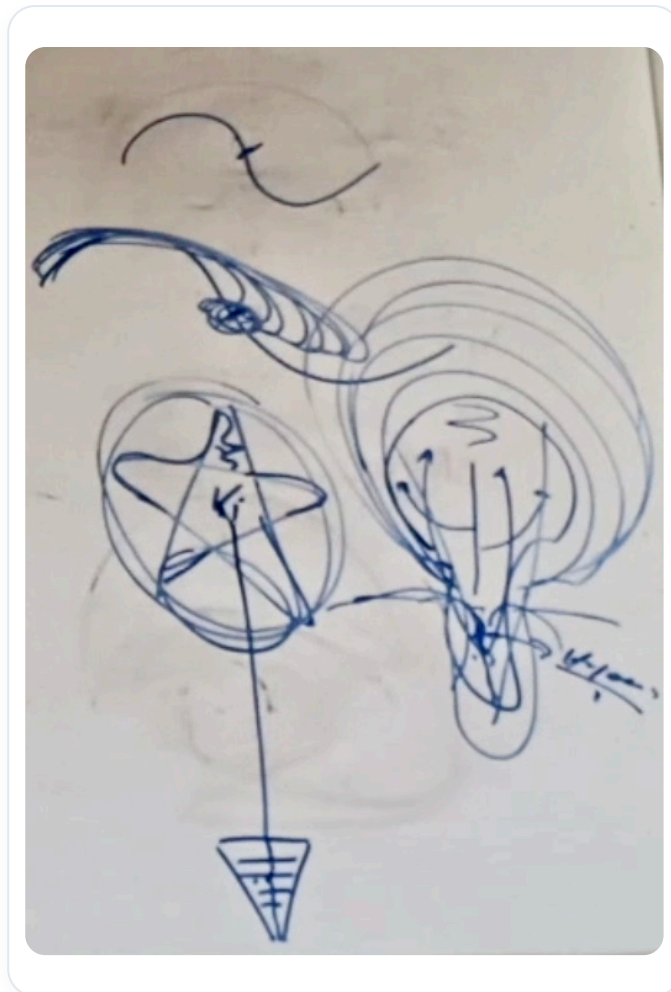


FIG. — Inicio del proceso epiblastico

Esta estructura es esencial porque constituye la base del **cráneo**, integrando elementos como la **hipófisis**, las **grandes alas del esfenoides**, el **sistema petroso**, el **sistema occipital** y el **etmoides**. Abajo, comienza el desarrollo del **sacro**, con el proceso de S2, que representa el vestigio de la línea primitiva. Este proceso se convierte en un punto de apoyo crucial, subrayando la importancia de un **sacro libre** para permitir una unidad funcional.

En esta fase de desarrollo, el embrión adquiere una forma similar a una raqueta, con la notocorda y la línea primitiva. Este proceso de crecimiento genera un campo de aspiración para formar el **mesodermo**, especialmente el campo precardíaco. El crecimiento anterior del embrión aspira el material hacia esta zona, arrastrando células en forma de **bottle cells** hacia el centro. Estas células liberan **ácido hialurónico**, esencial a nivel mesenquimático.

El eje notocordal es fundamental, ya que influye en la libertad de movimiento del sacro. Si el sacro está bloqueado, la columna vertebral no puede funcionar correctamente, lo que afecta la base del cráneo. Una base del cráneo no libre impide una buena **flexión-extensión**, lo que provoca un desequilibrio entre el **neurocráneo** y el **viscerocráneo**.

Esta dinámica está relacionada con la fuerza de ascenso del cráneo, donde el ojo se instala, y con la formación de un **tejido mesodérmico**. El crecimiento ectodérmico tira hacia arriba, mientras que el nódulo primitivo desciende hacia el sacro. Esto crea una zona de importancia para la

información proteica en relación con la madre.

Muchas **imágenes ancestrales** bloqueadas se encuentran entre el sigmoides y la vejiga, donde es crucial liberar esta información. Los problemas urogenitales pueden transmitirse a través de esta información, y la fuerza de migración descendente sacra juega un papel clave en este proceso.